TEMA 6 · Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS)

Resumen OPE Enfermería SMS · Profesiones sanitarias, ejercicio profesional, formación sanitaria especializada y continuada, desarrollo profesional y ejercicio privado

1. Objeto, ámbito y REPS

- **Ley 44/2003, de 21 de noviembre**, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS): la "constitución sectorial" de los recursos humanos en salud. Principios: corresponsabilidad, formación permanente, calidad y **seguridad del paciente**.
- Ámbito **universal**: obliga a todos los profesionales sanitarios, en el sector **público y en el privado**.
- **Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS)**: registro **público** con identidad, titulación, especialidad y lugar de ejercicio. Lo alimentan ministerios, CC. AA., colegios y centros públicos y privados. Permite al ciudadano verificar quién le atiende y combate el intrusismo.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La LOPS **no** es solo para la sanidad pública: también rige en clínicas y mutuas privadas.

2. Clasificación de las profesiones sanitarias

Grupo	Profesiones
Art. 2 · Licenciados / grado superior	**Medicina, Farmacia, Odontología y Veterinaria**
Art. 2 · Diplomados / grado	**Enfermería**, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica y Optometría, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética
Art. 3 · FP grado superior	Técnicos superiores: Dietética, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica y Citología, Radioterapia, Imagen para el Diagnóstico, Audiología Protésica (Grupo B)
Art. 3 · FP grado medio	**TCAE**

- La **Veterinaria** es profesión sanitaria universitaria por su papel en salud pública, zoonosis y seguridad alimentaria.
- El art. 3 se ampara en el **art. 35.1 CE** (derecho al trabajo y libre elección de profesión). El art. 5 obliga a integrar a los técnicos y a darles formación continuada.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Los técnicos superiores de FP están en el **art. 3**, no son titulados universitarios.

3. Ejercicio profesional (Título I, arts. 4-11)

- **Art. 7.2.a · Enfermería**: le corresponde **la dirección, evaluación y prestación de los cuidados** orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud y a la prevención. Es **autonomía técnica y funcional**: no es una profesión subordinada.
- Art. 7.2.b · Fisioterapia: tratamientos con medios y agentes físicos.
- **Art. 9**: trabajo en **equipo**, corresponsabilidad y delegación justificada, con historia clínica compartida.
- Acceso a la **gestión clínica** por sistemas objetivos y transparentes. **Art. 11**: la estructura asistencial debe estar disponible para docencia e investigación.

Requisitos para ejercer (art. 4)

1. **Título oficial** habilitante.
2. **No estar inhabilitado** ni suspendido (por sentencia o sanción colegial firme).
3. **Colegiación** cuando una ley estatal la exija (Enfermería: obligatoria también en la sanidad pública).

- Los **colegios profesionales** son **corporaciones de Derecho Público**: control deontológico y de la buena praxis. Su sanción firme de inhabilitación impide ejercer **en cualquier ámbito**, también en el SMS.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Trabajar en el SMS con plaza fija **no** exime de estar colegiada.

4. Formación de grado (Título II, cap. I-II)

- **Art. 12**: revisión permanente de la formación (evidencia, necesidades de la población, seguridad del paciente, evaluación de calidad).
- **Art. 13 · numerus clausus**: lo fijan los **Ministerios de Sanidad y Educación** (oído el Foro Profesional) según las **necesidades del SNS** y la **capacidad docente** de los centros.
- **Art. 14 · conciertos** universidad-servicio de salud: dan la condición de **Hospital Universitario** (sigue perteneciendo al SMS). Figuras: **profesor asociado** de Ciencias de la Salud (mantiene su plaza asistencial) y **plazas vinculadas** (un único nombramiento como clínico del SMS y profesor de universidad).

5. Formación Sanitaria Especializada (arts. 15-32)

- Carácter **oficial y estatal**, por **sistema de residencia** (MIR, EIR, FIR, PIR...) con **contrato de residencia** de carácter especial (**RD 1146/2006**).
- **Supervisión decreciente**: el residente de primer año tiene supervisión **directa y presencial**; después, de proximidad y de respaldo. La responsabilidad legal crece de forma progresiva.
- **Libro del Residente**: registro obligatorio de rotaciones, guardias, técnicas y evaluaciones.
- El **título de especialista** lo expide el **Ministerio de Sanidad** (en nombre del Rey), no la Comunidad Autónoma.

Especialidades de enfermería (RD 450/2005)

- Acceso por **examen EIR** estatal; **2 años** de residencia en unidad docente acreditada; evaluaciones anuales y final.
- Desarrolladas: **Obstétrico-Ginecológica (Matrona)**, **Familiar y Comunitaria**, **Salud Mental**, **Pediátrica**, **Geriátrica** y **del Trabajo**. **Cuidados Médico-Quirúrgicos**: recogida en la norma pero **sin desarrollar** (nunca se ha ofertado).

Segunda especialidad y ACE

- **Segunda especialidad (art. 23)**: exige **5 años** de ejercicio ininterrumpido en la primera, mismo tronco o afinidad, y prueba; la residencia se acorta. Para una tercera deben pasar **8 años**.
- **Áreas de Capacitación Específica (arts. 24-25)**: ultraespecialización sobre una especialidad. Dan un **diploma** (no un nuevo título); ratio **1 tutor : 1 residente**.

Estructuras docentes

Órgano	Claves
Comisión de Docencia (art. 27; RD 183/2008)	Preside el **Jefe de Estudios** (voto de calidad); vocales tutores y residentes (elegidos por **voto directo y secreto**); secretario administrativo **sin voto**. Quórum: mitad más uno; acuerdos por **mayoría simple**. Planifica, autoriza rotaciones, certifica evaluaciones e informa en expedientes disciplinarios
Tutor	Especialista de plantilla **acreditado** (el tutor "accidental" no existe). Derecho a tiempo protegido, formación y sustitución inmediata
Comisiones Nacionales de Especialidad (art. 28)	Una por especialidad: elaboran el **programa formativo**, los criterios de evaluación, auditan unidades docentes y proponen ACE
Consejo Nacional de Especialidades (art. 30)	Reúne a los presidentes de las Comisiones Nacionales; asesora a los Ministerios

TRAMPAS DE EXAMEN

! La Comisión de Docencia la preside el **Jefe de Estudios**, nunca el Gerente ni la Dirección de Enfermería.

! El programa formativo lo redacta la **Comisión Nacional** de la especialidad; el hospital lo aplica.

6. Formación continuada (arts. 33-36)

- Proceso de aprendizaje **activo y permanente**: es a la vez **derecho** del profesional y **deber** hacia los pacientes. La Administración debe facilitarla (planes, recursos, conciliación horaria).
- **Comisión de Formación Continuada del SNS (art. 34)**: criterios comunes de acreditación. Los **créditos CFC** valen en **todo el SNS**, la acredite la CA que la acredite.
- **Diplomas de Acreditación (DA) y de Acreditación Avanzada (DAA) (art. 36)**: certifican competencias en áreas funcionales transversales (dolor, paliativos, trasplantes). El DAA exige el DA previo. Según el manual, **vigencia de 5 años** y renovación.

7. Desarrollo profesional, ejercicio privado y Foro Profesional

- **Carrera profesional (Título III, arts. 37-39)**: reconocimiento **horizontal** e individual de conocimientos, experiencia y objetivos, **sin cambiar de puesto**. **Art. 38**: las CC. AA. deben **homologar** los grados entre sí (movilidad sin perder el nivel).
- **Ejercicio privado (Título IV, arts. 40-46)**: por cuenta propia o ajena, con los **mismos controles de calidad** que el SNS (historia clínica, consentimiento, bioseguridad).
- **Art. 46**: es **obligatorio** tener un **seguro de responsabilidad civil**, aval u otra garantía financiera para la asistencia en el sector privado.
- **Foro Profesional (Título V, arts. 47-50)**: Ministerios de Sanidad y Educación, CC. AA., colegios y sindicatos. Resuelve conflictos competenciales entre profesiones, participa en las normas y vela por la acreditación de la FSE.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Seguro de responsabilidad civil en la privada = **obligatorio** (art. 46).

! La carrera profesional permite progresar **sin** pasar a un puesto de gestión.